RATUNEK DLA UTKNIĘTEGO PRZYPADKU™ · TAJNY BONUS

Dziennik Przypadku: Rozwiązywanie utkniętych przypadków poprzez rejestrację

Metoda oparta na zapisach, a nie na pamięci: te same pomiary na każdej wizycie, znak utknięcia, analiza przyczyn źródłowych i zasada jednej zmiany.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Metoda: dlaczego dziennik?

Definiowanie utknięcia: zasada dwóch kontroli

Standard rejestracji: co wpisywać na każdej wizycie

Analiza przyczyn źródłowych: pięć pytań „dlaczego” i sześć obszarów

Zasada jednej zmiany i test

Wypełniony przykład

Szablon 1 · Karta rejestracji wizyty

Szablon 2 · Tabela śledzenia pomiarów

Szablon 3 · Formularz analizy przyczyn źródłowych

Szablon 4 · Podsumowanie zakończenia przypadku

METODA 01

Dlaczego dziennik?

W utkniętym przypadku tym, co najczęściej ginie, nie jest informacja, lecz zapis.

Pamięć zapamiętuje ostatnią kontrolę. Dziennik zapamiętuje całe leczenie. W utkniętym przypadku trudno podjąć właściwą decyzję, nie widząc, co i kiedy się zmieniło.

BEZ DZIENNIKA	Z DZIENNIKIEM
„Wydaje się, że trochę się poprawiło”.	Overjet na dwóch kontrolach taki sam: utknięcie.
Jednocześnie zmienia się łuk, wyciągi i zamki.	Jedna zmiana na raz; widać wynik.
Brak współpracy jest zgadywany.	Współpraca jest zapisywana słowami pacjenta na każdej wizycie.
Ten sam błąd powtarza się w następnym przypadku.	Podsumowanie zakończenia jest lekcją dla następnego przypadku.

Cztery części dziennika

1. Standard rejestracji
2. Znak utknięcia
3. Analiza przyczyn źródłowych
4. Jedna zmiana i test

METODA 02

Definiowanie utknięcia: zasada dwóch kontroli

Utknięcie definiuje pomiar, a nie odczucie.

Zasada dwóch kontroli

Jeśli pomiar docelowy etapu **nie zmienia się na dwóch kolejnych kontrolach** lub **zmienia się w niewłaściwym kierunku**, przypadek utknął. Należy zaznaczyć ten wiersz w dzienniku i przejść do analizy przyczyn źródłowych.

ETAP	POMIAR DOCELOWY	ZNAK UTKNIĘCIA
Niwelacja	Stłoczenie, rotacje	Rotacja lub stłoczenie bez zmian
Zamknięcie szpar	Pozostała przestrzeń (mm)	Przestrzeń bez zmian lub się powiększa
Korekta strzałkowa	Overjet, relacja kłów	Overjet bez zmian, relacja taka sama
Kierunek pionowy	Overbite (mm)	Overbite bez zmian lub w przeciwnym kierunku
Linia środkowa	Przesunięcie linii środkowej	Odchylenie takie samo lub nawrót
Zakończenie	Kontakty, korzenie, osadzenie	Ten sam brak na dwóch kontrolach

Uwaga: Czerwone flagi (ruchomość, zmiana koloru, recesja dziąseł, ból SSŻ) nie czekają na dwie kontrole. Należy zapisać i ocenić, gdy tylko je Pan/Pani zobaczy.

METODA 03

Standard rejestracji: co wpisywać na każdej wizycie

Te same obszary, ta sama kolejność, te same odniesienia.

OBSZAR	JAK WPISYWAĆ
Data i etap	Nazwa etapu i użyty łuk
Pomiary	Overjet, overbite, linie środkowe, relacja kłów i trzonowców, pozostała przestrzeń
Relacja pacjenta	Krótka notatka słowami pacjenta (ból, pęknięcie, współpraca)
Ustalenia	Higiena, tkanki, integralność aparatu
Wykonane czynności	Jeden wiersz: co się zmieniło?
Zadanie dla pacjenta	Jedno zdanie
Następny cel	Zmiana oczekiwana na następnej kontroli
Znak utknięcia	Tak / nie

Zasada odniesienia

Pomiary zawsze należy pobierać z tych samych punktów odniesienia. Jeśli odniesienie się zmieni, pomiarów nie można porównać.

METODA 04

Analiza przyczyn źródłowych: pięć pytań „dlaczego” i sześć obszarów

Od objawu do przyczyny: należy zadać pytanie „dlaczego?” pięć razy, a następnie przeszukać sześć obszarów.

Pięć pytań „dlaczego”

PYTANIE	PRZYKŁAD
1. Dlaczego przestrzeń się nie zamyka?	Kieł się nie przesuwa.
2. Dlaczego kieł się nie przesuwa?	Łuk blokuje się na drodze przesuwania.
3. Dlaczego się blokuje?	Przejście do zamykania nastąpiło przed zakończeniem poziomowania.
4. Dlaczego przejście nastąpiło za wcześnie?	Cel etapu nie był zapisany.
5. Dlaczego nie był zapisany?	Pole celów etapu w formularzu planowania było puste.

Piąta odpowiedź to często błąd systemu. Naprawienie go zapobiega utknięciu następnego przypadku.

Sześć obszarów

OBSZAR	CO SPRAWDZAĆ
Diagnoza	Czy lista problemów jest niepełna? Czy pominięto komponent szkieletowy?
Plan	Czy cele i potrzeba zakotwienia są zapisane? Czy kolejność jest poprawna?
Mechanika	Łuk, pozycja zamka, system sił, droga przesuwania
Aparaty	Integralność, aktywacja, dopasowanie
Pacjent	Współpraca, higiena, regularność wizyt, nawyki
Biologia	Ankyloza, korzeń, stan periodontologiczny, wzrost

METODA 05

Zasada jednej zmiany i test

Po znalezieniu przyczyny źródłowej: jedna zmiana, prognoza, dwie kontrole.

1. Należy wybrać **jedną zmianę** odpowiadającą przyczynie źródłowej.
2. Należy zapisać, czego oczekuje Pan/Pani po zmianie: jaki pomiar, w jakim kierunku?
3. Nie należy wprowadzać innych zmian przez dwie kontrole (z wyjątkiem czerwonych flag).
4. Należy zmierzyć i porównać z prognozą.
5. Jeśli prognoza się sprawdziła – kontynuować; jeśli nie – wrócić do sześciu obszarów.

Czy po zmianie pomiar docelowy zmienił się w oczekiwanym kierunku?

↓

Tak → Kontynuować, usunąć znak utknięcia w dzienniku.

Nie → Wrócić do analizy przyczyn źródłowych; sprawdzić następny obszar.

PRZYKŁAD

Wypełniony przykład

Jak wypełniać dziennik na przykładzie fikcyjnego przypadku.

Przypadek: Fikcyjny pacjent, leczenie z ekstrakcją górnych przedtrzonowców, etap zamykania przestrzeni.

KONTROLA	POZOSTAŁA PRZESTRZEŃ (PRAWA / LEWA)	WYKONANE CZYNNOŚCI	UTKNIĘCIE
1	Zmierzono	Rozpoczęto zamykanie	Nie
2	Prawa zmalała, lewa bez zmian	Aktywacja odnowiona	Nie
3	Lewa nadal bez zmian	Analiza przyczyn źródłowych	**Tak**
4	Lewa zaczęła maleć	Usunięto przeszkodę okluzyjną po lewej stronie (jedna zmiana)	W obserwacji
5	Lewa maleje	Kontynuacja	Usunięto

Przyczyna źródłowa (przykład)

Po lewej stronie zauważono, że ząb w przeciwstawnym łuku styka się z przesuwanym zębem. Zmiana: usunięcie przeszkody okluzyjnej. Prognoza: lewa przestrzeń zmaleje w ciągu dwóch kontroli. Wynik: prognoza się sprawdziła.

SZABLON 1

Karta rejestracji wizyty • Strona 1

Każdy wiersz to wizyta. Nie należy zostawiać pustej kolumny utknięcia.

Pacjent

Początek leczenia

DATA	ETAP / ŁUK	OJ / OB	LINIA ŚRODKOWA	RELACJA P/L	PRZESTRZEŃ	WYKONANE CZYNNOŚCI	ZADANIE	UTKNĘŁO?

SZABLON 1

Karta rejestracji wizyty · Strona 2

Każdy wiersz to wizyta. Nie należy zostawiać pustej kolumny utknięcia.

Pacjent

Początek leczenia

DATA	ETAP / ŁUK	OJ / OB	LINIA ŚRODKOWA	RELACJA P/L	PRZESTRZEŃ	WYKONANE CZYNNOŚCI	ZADANIE	UTKNĘŁO?

SZABLON 2

Tabela śledzenia pomiarów

Należy zobaczyć cele pomiarów obok siebie. Każda kolumna to kontrola.

Pacjent

Etap

POMIAR	POCZ.	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	CEL
Overjet (mm)										
Overbite (mm)										
Linia środkowa górna										
Linia środkowa dolna										
Relacja kła prawego										
Relacja kła lewego										
Relacja trzonowca prawego										
Relacja trzonowca lewego										
Pozostała przestrzeń prawa (mm)										
Pozostała przestrzeń lewa (mm)										
Stłoczenie (mm)										
Notatka o higienie / tkankach										

SZABLON 3

Formularz analizy przyczyn źródłowych • Formularz 1

Należy wypełnić po postawieniu znaku utknięcia.

Pacjent

Data

Utknięty pomiar

Od ilu kontroli bez zmian?

Pięć pytań „dlaczego”

1. Dlaczego?

2. Dlaczego?

3. Dlaczego?

4. Dlaczego?

5. Dlaczego?

Przeszukiwanie sześciu obszarów

OBSZAR	USTALENIA	CZY TO MOŻE BYĆ PRZYCZYNA?
Diagnoza		Tak / Nie
Plan		Tak / Nie
Mechanika		Tak / Nie
Aparaty		Tak / Nie
Pacjent		Tak / Nie
Biologia		Tak / Nie

Decyzja

Przyczyna źródłowa

Jedna zmiana

Oczekiwany wynik (pomiar i kierunek)

Data kontroli

Wynik

Czy wymagane skierowanie?

SZABLON 3

Formularz analizy przyczyn źródłowych • Formularz 2

Należy wypełnić po postawieniu znaku utknięcia.

Pacjent

Data

Utknięty pomiar

Od ilu kontroli bez zmian?

Pięć pytań „dlaczego”

1. Dlaczego?

2. Dlaczego?

3. Dlaczego?

4. Dlaczego?

5. Dlaczego?

Przeszukiwanie sześciu obszarów

OBSZAR	USTALENIA	CZY TO MOŻE BYĆ PRZYCZYNA?
Diagnoza		Tak / Nie
Plan		Tak / Nie
Mechanika		Tak / Nie
Aparaty		Tak / Nie
Pacjent		Tak / Nie
Biologia		Tak / Nie

Decyzja

Przyczyna źródłowa

Jedna zmiana

Oczekiwany wynik (pomiar i kierunek)

Data kontroli

Wynik

Czy wymagane skierowanie?

SZABLON 4

Podsumowanie zakończenia przypadku

Należy wypełnić po zakończeniu leczenia: lekcja dla następnego przypadku.

Pacjent

Początek i koniec leczenia

Początkowa lista problemów

Liczba utknięć

Najdłużej trwający etap

UTKNIĘCIE	PRZYCZYNA ŹRÓDŁOWA	ZMIANA	WYNIK
1			
2			
3			
4			
5			

Co zrobię inaczej w następnym przypadku

Dodam do mojego formularza planowania

Specjalna notatka dotycząca retencji

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Po znalezieniu przyczyny źródłowej utkniętego przypadku należy otworzyć odpowiedni scenariusz w **60 Scenariuszach Utkniętych Przypadków**. Aby ustalić plan na nowo, należy użyć **Narzędzia 4 · 4-Etapowy Planer Kliniczny**, a dla powtarzających się błędów planowania – **Narzędzia 5 · Radar Błędów Planowania**.